



FACULTAD DE OBSTETRICIA Y ENFERMERÍA
“HILDA ZORAIDA BACA NEGLIA”
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

TESIS
ADOPCIÓN DEL ROL MATERNAL DE LAS MADRES PRIMERIZAS
EN EL CUIDADO DEL NIÑO MENOR DE 1 AÑO, EN EL SERVICIO
DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL CENTRO DE SALUD
MIRONES BAJO, 2024

PARA OPTAR
EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN ENFERMERÍA

PRESENTADO POR:
CARLA IVETTE CARRASCO VILLARREAL

ASESORA:
DRA. MARGOT JESSICA DE LA CRUZ SALAZAR

LIMA, PERÚ

2025

**ADOPCIÓN DEL ROL MATERNAL DE LAS MADRES PRIMERIZAS
EN EL CUIDADO DEL NIÑO MENOR DE 1 AÑO, EN EL SERVICIO
DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL CENTRO DE SALUD
MIRONES BAJO, 2024**

ASESORA Y MIEMBROS DEL JURADO

Asesora:

Dra. Margot Jessica De la Cruz Salazar

Miembros del jurado:

Presidenta: Dra. Ysabel Cristina Carhuapoma Acosta

Vocal: Mg. Eulalia María Chahuas Rodríguez

Secretaria: Mg. Janet Guevara Casas

DEDICATORIA

A Dios por darme la oportunidad de alcanzar
unas de mis metas de esta bonita carrera, a
mis padres, mi hermano por su apoyo.

AGRADECIMIENTO

A la Dra. Margot Jessica de la Cruz Salazar quien desde el día uno, me brindo sus conocimientos y dedicación permitiéndome la ejecución para llevar acabo mi estudio.

A la Lic. Linda Alfaro mi docente del Internado comunitario, agradecida por su apoyo y por brindarme la oportunidad de elaborar mi tesis en el Centro de Salud Mirones Bajo.

ÍNDICE DE CONTENIDO

	Pág.
TÍTULO	ii
ASESORA Y MIEMBROS DEL JURADO	iii
DEDICATORIA.....	iv
AGRADECIMIENTO.....	v
ÍNDICE DE CONTENIDO.....	vi
ÍNDICE DE TABLAS	vii
RESUMEN	ix
ABSTRACT	x
I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. MATERIAL Y MÉTODOS	6
2.1. Diseño metodológico.....	6
2.2. Población y muestra.....	6
2.3. Criterios de selección	6
2.4. Técnicas de recolección de datos	7
2.5. Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información	9
2.6. Aspectos éticos	9
III. RESULTADOS	10
IV. DISCUSIÓN	21
V. CONCLUSIONES	44
VI. RECOMENDACIONES.....	46
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	47
VII. ANEXOS	60

ÍNDICE DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1. Adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del niño menor de 1 año, en el servicio de crecimiento y desarrollo del Centro de Salud Mirones Bajo ,2024.....	11
Tabla 2. Adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del niño menor de 1 año en la dimensión aceptación del bebé	12
Tabla 3. Adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del niño menor de 1 año en la dimensión contacto con el rol de la madre	13
Tabla 4. Adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del niño menor de 1 año en la dimensión estimulación del bebé	14
Tabla 5. Adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del niño menor de 1 año en la dimensión expresiones maternas de afecto hacia él bebé.....	15
Tabla 6. Adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del niño menor de 1 año en la dimensión bienestar al bebé.....	16

Tabla 7. Adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del niño menor de 1 año en la dimensión preocupación y protección del bebé	17
Tabla 8. Adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del niño menor de 1 año en la dimensión interacción con la pareja respecto al bebé.....	18
Tabla 9. Adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del niño menor de 1 año en la dimensión interacción con la familia de origen respecto al bebé.....	19
Tabla 10. Adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del niño menor de 1 año en la dimensión cuidados del bebé	20
Tabla 11. Adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del niño menor de 1 año en la dimensión conocimiento y cultura relacionados al bebé.....	21

RESUMEN

Objetivo: Determinar la adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del niño menor de 1 año, en el servicio de crecimiento y desarrollo del Centro de Salud Mirones Bajo, 2024. **Método:** Estudio de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, y de tipo descriptivo, prospectivo, de corte transversal. La población total es de 100 madres. La muestra estuvo integrada por 79 madres primerizas. La técnica que se utilizó es la encuesta, como instrumento se aplicó un cuestionario titulado “Escala de Adopción del Rol Materno” cuyos autores son Garrido y Marchan. La confiabilidad se realizó con un alfa de Cronbach 0.94, indicando que es confiable. **Resultados:** Se evidenció que el 98% (77) presentaron un nivel alto, y el 2% (2) de las madres primerizas presentaron un nivel medio en la adopción del rol maternal. **Conclusiones:** Las madres primerizas atendidas en el Centro de Salud Mirones Bajo presentan un nivel alto en la adopción del rol maternal.

Palabras claves: rol, maternal, lactante.

ABSTRACT

Objective: To determine the adoption of the maternal role of first-time mothers in the care of infants under 1 year of age, in the growth and development service of the Madrones Bajo Health Center, 2024 **Method:** This study was quantitative, non-experimental, and descriptive, prospective, cross-sectional. The total population was 100 mothers. The sample consisted of 79 first-time mothers. The survey technique used was the instrument used to administer a questionnaire titled "Maternal Role Adoption Scale," authored by Garrido and Marchan. Reliability was determined with a Cronbach's alpha of 0.94, indicating that it is reliable. **Results:** It was shown that 98% (77) presented a high level, and 2% (2) of the first-time mothers presented a medium level in the adoption of the maternal role. **Conclusions:** New mothers treated at the Mirones Bajo Health Center show a high level of maternal role adoption.

Key words: Role, maternal, infant.

I. INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la salud (OMS)¹ 2022, el África subsahariana representó el 57% de todas las defunciones de menores de 5 años. Dicha región reportó incidencia más elevada, seguida de Asia Central y meridional con una tasa de mortalidad neonatal de 21 defunciones por cada 1000 nacidos vivos. Las principales causas de estas muertes incluyen el parto prematuro, infecciones neonatales y las anomalías congénitas.

En el mismo contexto en Sudamérica, específicamente en Uruguay, en el 2024, se estimó el 57% de las muertes estimadas en menores de 5 años se concentran en los primeros 28 días de vida.² Además, en el 2022, se estimaron 152.000 las defunciones de menores de 5 años, lo que simboliza una reducción de 60%, la meta para reducir las tasas de mortalidad se centra en que el sistema priorice la prestación de atención primaria de calidad, garantizando la implementación de intervenciones esenciales y de un tratamiento oportuno. Estos indicadores demuestran falta adopción del rol maternal.

Según Ramona Mercer, en el 2025, el rol maternal se centra cambio y adaptación donde la madre enfrenta grandes retos a la nueva identidad, creando un vínculo esencial de amor, protección y cuidado desde el embarazo hasta primeros años de vida.³

Esta se ha deteriorado por diversas razones, en la forma como las madres adoptan su rol; tales como la edad materna, nivel socioeconómico, trabajo por tiempo prologando y falta de apoyo paternal y familiar.

A consecuencia de ello, se evidenciaría un rol maternal de nivel bajo, donde habría desapego madre e hijo, falta de aceptación del bebe, retraso en el crecimiento y desarrollo.⁴

De este modo, el cuidado es significativo y transformador ante el gran desafío de convertirse en madre. Su teoría adopción rol materno incluye 10 componentes fundamentales aceptación del bebé, contacto con el rol de madre, estimulación del bebé, expresiones maternas de afecto hacia él bebé, bienestar del bebé, preocupación y protección al bebé, interacción con la pareja, interacción con la familia, cuidados del bebé, conocimiento y cultura.

Por un lado, Marín et al.⁵ 2024, realizó un estudio en México titulado "Rol en madres primigestas en el primer nivel de atención". Sus resultados evidencian que el 71% presentan un nivel alto adopción del rol maternal. Las mayorías de las madres tienen edades entre 16 y 18 años (35 %).

Mientras que Cadena et al.⁶ 2022, en Colombia, detalla en su investigación "Adopción rol maternos en madres a partir de la teoría de Ramona Mercer" que el 86% de las madres primerizas presentan un nivel medio adopción del rol maternal. Por su parte, Verde et al.⁷ 2020, un estudio titulado "Adopción del rol materno en primíparas según Ramona Mercer" donde 89% de las madres tiene buena adopción del rol maternal.

Estos estudios revelan que la adopción del rol maternal, se puede producir por diversos elementos como la familia, pareja, el ambiente. Donde destacan la calidad respecto a la adopción maternal, enfocados en la teoría de Merced.

Es importante destacar el rol fundamental que desempeñan las madres primerizas en el cuidado del lactante menor, en su primer encuentro con él bebe. Por lo tanto, es esencial que le brinde dedicación, responsabilidad y compromiso para asegurar

que el cuidado se lleve a cabo de manera oportuna, considerando el apego que se va formando hacia el niño.⁸

A nivel Nacional en el Perú⁹, en el 2023, se calcula las mujeres tuvieron alrededor de dos hijos durante su vida reproductiva. La fecundidad en madres primerizas ha mostrado una disminución significativa del 24.8%. Mientras que en el año 2000 se registraban 74.2 nacimientos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 19 años de edad, para el 2023 esta cifra bajó a 55.8%.

Esta problemática también afecta directamente al Perú. Según datos proporcionados por ENDES¹⁰, en 2023, nos mostró las estadísticas de las madres primerizas tienen en promedio 1,9 hijos. De acuerdo a la residencia, en el en el área rural las mujeres tienen 2,8 hijos a comparación, en el área urbana 1,7 hijos. En ese mismo año, en el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)¹¹, anunció 8 millones 891 mil madres. De este total, el 60,1% corresponde a mujeres 15 a 49 años de edad, es decir, promedio de la madre al momento del nacimiento de su primer hijo es de 22 años.

Acorde a los datos reportados por el Ministerio de Salud (MINSA)¹² en el 2024, registra la situación epidemiológica de la muerte neonatal, se evidencia que en el 2021 hubo 2958 muertes, en 2022 hubo 2877 muertes, y en el 2024 15 muertes, indicando que las tasas de mortalidad han ido decreciendo.

También se tiene a la NTS¹³, con RM N°537, tiene como propósito mejorar la salud y el DIT, con el fin de que el profesional de la salud brinde a las madres una atención integral.

Como expresa Ramona¹⁴ en el 2023, nos refiere en su teoría que existe una transformación que sucede durante la maternidad. Al profundizar en su teoría, es donde la madre desarrolla un vínculo con su hijo, experimentando placer,

gratificación y una sensación de armonía en este nuevo rol, lo que refuerza su identidad como madre.

Esta investigación, es fundamental dado, que hay mucha desconfianza y miedo por parte de las madres primerizas frente a los cuidados de su menor hijo, ya que, por su inexperiencia de la llegada de su niño, no tienen suficientes conocimientos para que puedan asumir su nuevo rol. Cabe resaltar, que estos resultados contribuirán a concientizar a los enfermeros, además de crear estrategias, como capacitaciones continuas; además de detectar las debilidades.

Durante mi rotación de internado en el Centro de Salud Mirones Bajo, en el servicio de CRED, las madres primerizas referían “quiero aprender más del cuidado de mi hijo”, “el ser madre por primera vez se me hace muy difícil”, “cuando mi hijito llora no sé qué hacer”. Además de ello, al realizar la evaluación de enfermería, se pudo percibir que las madres no tienen afecto hacia sus hijos, se ha observado que las madres primerizas no asumen su rol, quienes lo asumen son las abuelas, visualizando un desapego madre e hijo.

Por lo manifestado, se formula el siguiente problema de investigación. ¿Cuál es la adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del niño menor de 1 año, en el servicio de crecimiento y desarrollo del Centro de Salud Mirones Bajo ,2024?

En este estudio se planteó como objetivo general: Determinar la adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del niño menor de 1 año, en el servicio de crecimiento y desarrollo del Centro de Salud Mirones Bajo ,2024; y como objetivos específicos: Identificar la adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del niño menor de 1 año, en la dimensión aceptación del bebe, contacto con el rol de la madre, estimulación del bebe, expresiones

maternales de afecto hacia él bebe, bienestar al bebe, preocupación y protección del bebé, interacción con la pareja respecto al bebé, interacción con la familia de origen respecto al bebé, cuidados del bebé , expresiones maternales de afecto hacia él bebé y conocimiento y cultura relacionados al bebe.

II. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Diseño metodológico

Investigación de enfoque cuantitativo, según Hernández ¹⁵ indica que son medidos y cuantificables, de tipo descriptivo según Arias et al.¹⁶ ya que se caracteriza por observar y describir la variable de estudio, prospectivo son datos obtenidos en tiempo presente y de corte transversal ya que se da en un determinado momento.¹⁷

2.2. Población y muestra

2.2.1. Población

Los datos estadísticos del Centro de salud Mirones Bajo registraron 100 madres en un periodo de dos meses.

2.2.2. Muestra

Estuvo conformada por 79 madres primerizas. Aplicando muestreo probabilístico aleatorio simple. **(ANEXO 6)**

2.3. Criterios de selección

Criterios de inclusión:

- Madres mayores de 18 años.
- Madres que asisten en el periodo de ejecución.

Criterios de exclusión:

- Madres que no deseen participar voluntariamente en el estudio.
- Madres de niños que tengan condición asegurada.

2.4. Técnicas de recolección de datos

Se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario llamado “Escala de Adopción del Rol Materno”, creado por Garrido y validado por Marchan en 2011, Perú, con una confiabilidad 0,94 lo que demuestra que el instrumento es confiable.

El instrumento consta de 56 preguntas de tipo Likert, distribuidos en diez dimensiones con parámetros valorativos como: Aceptación del bebe (10), contacto con el rol de madre (6), estimulación del bebé (7), expresiones maternas de afecto hacia él bebé (5), bienestar del bebé (5), preocupación y protección al bebé (5), interacción con la familia de origen respecto al bebé (5), interacción con la pareja respecto al bebé (5), cuidados del bebé (3), conocimiento y cultura relacionados al bebé (5).

Rangos de medición global:

CATEGORIAS	ADOPCIÓN DEL ROL MATERNAL
ALTO	169 - 224
MEDIO	113 - 168
BAJO	56 - 112

Rangos de medición global:

CATEGORIAS	Aceptación del bebe	Contacto con el rol de la madre	Estimulación del bebe	Expresiones maternas de afecto hacia él bebe	Bienestar del bebe
ALTO	31 - 40	19 -24	22 - 28	16 - 20	16 - 20
MEDIO	21 - 30	13 -18	15 - 21	11 - 15	11 - 15
BAJO	10 - 20	6 -12	7 - 14	5 - 10	5 - 10

CATEGORIAS	Preocupación y protección del bebe	Interacción con la pareja respecto al bebe	Interacción con la familia de origen respecto al bebe	Cuidados del bebe	Conocimiento y cultura relacionado al bebe
ALTO	16 - 20	16 - 20	16 - 20	10 -12	16 - 20
MEDIO	11 - 15	11 - 15	11 - 15	7 - 9	11 - 15
BAJO	5 - 10	5 - 10	5 - 10	3 - 6	5 - 10

La recolección de datos se llevó a cabo en el servicio de CRED del Centro de Salud Mirones Bajo (noviembre y diciembre del 2024). La investigadora responsable coordinó previamente con el personal del servicio para que el proceso de recolección se realizara durante el CRED.

En el desarrollo de este proceso se brindó las indicaciones pertinentes. Previo a ello, se les entregó el consentimiento informado y, en todo momento, se resolvieron las inquietudes de las madres respecto a las preguntas del cuestionario, al concluir el cuestionario, las madres plantearon

diversas interrogantes las cuales la investigadora abordó de manera detallada para proporcionar una mayor claridad sobre ello.

2.5. Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información

El procesamiento de datos fue en el software estadístico SPSS24, para posteriormente representarla mediante tablas de frecuencia y porcentajes, aplicando la estadística descriptiva.

2.6. Aspectos éticos

Fue aprobado por el Comité Institucional de Ética de la USMP, debido a que el estudio no es experimental con seres humanos, no se violó ningún principio ético en su realización de dicho estudio. Se aplicó los siguientes principios bioéticos:

Autonomía: Se respetó la decisión de la población de intervenir libremente, firmando el consentimiento informado.

Beneficencia: Mediante los resultados se buscó optimizar las medidas que ayudaron a mejorar el rol maternal.

No maleficencia: No ocasionó ningún daño físico, ni psicológico en los participantes.

Justicia: Se respetó creencias y costumbres de los participantes, brindando trato equitativo.

III. RESULTADOS

Tabla 1. Adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del niño menor de 1 año, en el Servicio de CRED del Centro de Salud Mirones Bajo, 2024.

CATEGORÍAS	N	%
Nivel Alto	77	98
Nivel Medio	2	2
Nivel Bajo	0	0
Total	79	100

En la Tabla 1, se observa que del 100% del total de la población el 98% (77) presentaron un nivel alto, y el 2% (2) de las madres primerizas presentaron un nivel medio en la adopción del rol maternal.

Tabla 2. Adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del niño menor de 1 año en la dimensión aceptación del bebé.

CATEGORÍAS	N	%
Nivel Alto	0	0
Nivel Medio	68	86
Nivel Bajo	11	14
Total	79	100

En la Tabla 2, se observa que del 100% del total de la población, el 86% (68) presentaron un nivel medio en la adopción del rol maternal, seguidamente el 14% (11) de las madres primerizas presentaron un nivel bajo en la dimensión aceptación del bebé.

Tabla 3. Adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del niño menor de 1 año en la dimensión contacto con el rol de la madre.

CATEGORÍAS	N	%
Nivel Alto	1	1
Nivel Medio	71	90
Nivel Bajo	8	9
Total	79	100

En la Tabla 3, se observa que del 100% del total de la población, el 90% (71) presentaron un nivel medio en la adopción del rol maternal, seguidamente el 9% (8) presentaron un nivel bajo, y el 1%(1) de las madres primerizas presentaron un nivel alto, en la dimensión contacto con el rol de la madre.

Tabla 4. Adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del niño menor de 1 año en la dimensión estimulación del bebé.

CATEGORÍAS	N	%
Nivel Alto	78	99
Nivel Medio	1	1
Nivel Bajo	0	0
Total	79	100

En la Tabla 4, se observa que del 100% del total de la población, el 99% (78) presentaron un nivel alto en la adopción del rol maternal, seguidamente el 1% (1) de las madres primerizas presentaron un nivel medio de las madres primerizas en la dimensión estimulación del bebé.

Tabla 5. Adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del niño menor de 1 año en la dimensión expresiones maternas de afecto hacia él bebé.

CATEGORÍAS	N	%
Nivel Alto	76	96
Nivel Medio	3	4
Nivel Bajo	0	0
Total	79	100

En la Tabla 5, se observa que del 100% del total de la población, el 96% (76) presentaron un nivel alto en la adopción del rol maternal, seguidamente el 4% (3) de las madres primerizas presentaron un nivel medio en la dimensión expresiones maternas de afecto hacia él bebé.

Tabla 6. Adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del niño menor de 1 año en la dimensión bienestar al bebé.

CATEGORÍAS	N	%
Nivel Alta	79	100
Nivel Medio	0	0
Nivel Bajo	0	0
Total	79	100

En la Tabla 6, se observa que del 100% del total de la población, el 100% (79) presentaron un nivel alto en la adopción del rol maternal de las madres primerizas en la dimensión bienestar al bebé.

Tabla 7. Adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del niño menor de 1 año en la dimensión preocupación y protección del bebé.

CATEGORÍAS	N	%
Nivel Alto	78	99
Nivel Medio	1	1
Nivel Bajo	0	0
Total	79	100

En la Tabla 7, se observa que del 100% del total de la población, el 99% (78) presentaron un nivel alto en la adopción del rol maternal, seguidamente el 1% (1) de las madres primerizas presentaron un nivel medio en la dimensión preocupación y protección del bebé.

Tabla 8. Adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del niño menor de 1 año en la dimensión interacción con la pareja respecto al bebé.

CATEGORÍAS	N	%
Nivel Alto	75	95
Nivel Medio	4	5
Nivel Bajo	0	0
Total	79	100

En la Tabla 8, se observa que del 100% del total de la población, el 95% (75) presentaron un nivel alto en la adopción del rol maternal, seguidamente el 5% (4) de las madres primerizas presentaron un nivel medio en la dimensión interacción con la pareja respecto al bebé.

Tabla 9. Adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del niño menor de 1 año en la dimensión interacción con la familia de origen respecto al bebé.

CATEGORÍAS	N	%
Nivel Alto	73	92
Nivel Medio	6	8
Nivel Bajo	0	0
Total	79	100

En la Tabla 9, se observa que del 100% del total de la población, el 92% (73) presentaron un nivel alto en la adopción del rol maternal, seguidamente el 8% (6) de las madres primerizas presentaron un nivel medio en la dimensión interacción con la familia de origen respecto al bebé.

Tabla 10. Adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del niño menor de 1 año en la dimensión cuidados del bebé.

CATEGORÍAS	N	%
Nivel Alta	79	100
Nivel Medio	0	0
Nivel Bajo	0	0
Total	79	100

En la Tabla 10, se observa que del 100% del total de la población, el 100% (79) presentaron un nivel alto de las madres primerizas en la dimensión cuidados del bebé.

Tabla 11. Adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del niño menor de 1 año en la dimensión conocimiento y cultura relacionados al bebé.

CATEGORÍAS	N	%
Nivel Alto	45	57
Nivel Medio	34	43
Nivel Bajo	0	0
Total	79	100

En la Tabla 11, se observa que del 100% del total de la población, el 57% (45) presentaron un nivel alto en la adopción del rol maternal, seguidamente el 43% (34) de las madres primerizas presentaron un nivel medio en la dimensión conocimiento y cultura relacionados al bebé.

IV. DISCUSIÓN

Con respecto al objetivo general, la investigación realizada, en el Centro de Salud Mirones Bajo, evidencia que el 98% (77) presentaron un nivel alto, y el 2% (2) un nivel medio en la adopción del rol maternal.

Resultados similares a la investigación de Vásquez et al ²⁴ nos revela que las madres que cuentan con un apoyo familiar, presentan un nivel alto 30,76% en la adopción del rol maternal.

Hallazgos diferentes nos revela el estudio de Garrido et al.¹⁸, se estimó que el 60% madres presentan un nivel medio.

Así mismo, Santander et al.¹⁹, encontró que el 95,1% de madres presentan niveles bajos de adopción al rol materno y el 4,9% nivel medio. Del mismo modo Gonzales et al.²¹, nos muestra que el 43,33% de madres tienen un rol maternal bajo.

Los resultados de la investigación comprueban que las madres presentan un nivel alto en la adopción rol maternal, a comparación de los resultados de Garrido y Stander quienes reportaron un nivel medio y bajo respectivamente.

Al analizar los resultados de Garrido y Stander, se observa que las poblaciones encuestadas tienen un grado de instrucción de secundaria incompleta, resultado diferente al estudio presentado, donde la población tienen secundaria completa. Rogers et al.²⁵ refiere que los factores culturales influyen en la adopción del rol materno, como el nivel de instrucción, lo que indica que tener menos acceso a la información, puede generar una mayor inseguridad en la toma de decisiones.

Figueiredo et al.²⁶ indica que el rol maternal puede verse afectada por múltiples factores, como socioculturales tales como: apoyo familiar y la pareja, y nivel educativo, en la presente investigación con respecto al indicador la pareja y la madre comparte el cuidado del niño ,estos resultados demuestra que el padre que forma parte de la familia brinda un buen apoyo, así mismo el 75% de mi población tiene un nivel de instrucción alto, estos indicadores demuestra los resultados encontrados en el presente estudio. Por otro lado, factores emocionales tales como: baja autoestima, falta de confianza en sí misma, todo ello refleja una carga negativa que pueden obstaculizar este proceso, donde pueden ser necesarias las intervenciones que apoyen bienestar emocional durante la adopción del rol maternal.

Mercer¹⁴, en su teoría el rol maternal nos refiere que es un proceso transición y adaptación donde la madre enfrenta grandes retos, en la cual la madre experimenta placer y gratificación a su identidad como madre, como principal característica es la conexión emocional con su bebé, logrando confianza y seguridad a través de retos y experiencias durante la maternidad.

Al mismo tiempo Rubín²², considera que es un proceso evolutivo mediante el cual mujer adquiere competencias en el cuidado y experimenta satisfacción en el desempeño de su nuevo rol. Este proceso, la mujer desarrolla su identidad materna y aprende a desempeñar dicho papel, ofreciendo un marco teórico que permite comprender la adaptación de la mujer a su nuevo rol.

Robles et al.²⁷, define que el rol maternal constituye un conjunto de comportamientos y emociones, esta responsabilidad no es innata, sino que se

construye progresivamente a través de la experiencia, ejerciendo en su desarrollo psicológico, social y emocional.

Según las definiciones mencionadas, esto demuestra que es un proceso que se inicia desde el embarazo hasta los primeros años de vida, donde la madre experimenta un viaje de crecimiento personal, experimentando un vínculo afectivo, satisfacción y armonía a su nueva identidad materna.

Según la NTS para el CRED¹³, señala que la enfermera es responsable de evaluar a la niña y el niño desde los 2 días de nacido y posterior a ello un control cada semana, en cada visita al servicio de crecimiento y desarrollo, la enfermera educa a la madre, sobre los cuidados esenciales para fortalecer prácticas de lactancia materna, higiene cordón umbilical, vacunas, baño diario, afecto, interacción y la importancia de cumplir con los controles. Esta etapa de la valoración la enfermera puede identificar cuáles son las necesidades que tiene madres y que puedan interferir en la adopción rol maternal, para luego realizar un seguimiento y desarrollar estrategias garantizando el bienestar del niño.

Desde su enfoque, la teórica Mercer hace mención que la enfermera tiene un papel clave en la orientación y asesoramiento a las madres sobre la adopción del rol maternal, favoreciendo un ambiente de confianza durante su proceso de maternidad. Esta combinación de roles asegura la salud y el bienestar óptimo del niño.

Con respecto al primer objetivo específico, se encontró que el 86% (68) presentaron un nivel medio, y el 14% (11) de las madres primerizas presentaron un nivel bajo en la dimensión aceptación del bebé.

Estos resultados son similares con la investigación de Mantilla et al.²⁰, quien obtuvo 23% (7) presentaron un nivel medio en la dimensión aceptación del bebé.

Dichos resultados son diferentes a los Santander et al.¹⁹ estimó que el 97% de las madres presentan un nivel bajo. De igual forma Gonzales et al.²¹, demostró que el 50% de madres primerizas presentan nivel bajo.

Los resultados de este estudio, comprueban que las madres presentan un nivel medio, a comparación de los resultados de Santander y Gonzales quienes reportaron un nivel bajo en la dimensión aceptación del bebé.

Tras analizar estos datos de Santander y Gonzales, se observa que las poblaciones encuestadas presentan un nivel bajo, resultado diferente al estudio presentado donde la población presenta un nivel medio. Heras et al.²⁸ refiere que los factores sociales influyen en la aceptación del bebé, lo que indica que no está preparada ni física, ni psicológicamente para asumir el rol de ser madre.

Logan et al.²⁹ refiere que aceptación del bebe puede atribuirse a múltiples factores, como emocionales tales como: falta de confianza en sí misma y depresión, en la presente investigación con respecto al indicador la madre le cuesta aceptar a su niño, estos resultados demuestran que la madre no está preparada ni física, ni psicológicamente para ejercer su rol materno, así mismo con respecto indicador la madre considera que no es necesario que si hijo asista al control CRED ,estos indicadores demuestra que las madres no muestran interés en el bienestar de su niño.

Villarreal ³⁰ indica que es un proceso en que la madre acepta con alegría la llegada de su hijo, dándole un lugar central en su vida, mostrando cercanía emocional y compromiso con su cuidado es decir que se inicia desde el momento en que la madre establece un vínculo afectivo amor y responsabilidad.

Marchan et al.¹⁸ considera que es un proceso mediante el cual la madre recibe con agrado la llegada del niño, dándole importancia, sintiéndose a gusto al interactuar con él y mostrando disposición para atender sus propias necesidades.

Conforme a lo expresado anteriormente, es un proceso que establece un vínculo afectivo, por el cual la madre comienza a desarrollar sentimientos de amor, protección y conexión emocional, fortaleciendo bienestar emocional de su identidad materna.

Según la NTS para el CRED¹³, indica que la enfermera es responsable de realizar un trabajo multidisciplinario en el primer nivel de atención, durante la evaluación es importante observar si las madres necesitan de un apoyo profesional, ya que muchas de ellas, al ser primerizas, suelen mostrarse inseguras al momento de responder preguntas durante la entrevista, debido al temor que sienten al interactuar por primera vez con la enfermera. En esa etapa de valoración la enfermera tiene que brindar un apoyo emocional, que promueva un vínculo seguro y de calidad, para luego realizar un seguimiento garantizando el bienestar de la madre.

Con respecto al segundo objetivo específico, se obtuvo que el 90% (71) presentaron un nivel medio, seguidamente el 9% (8) de las madres primerizas presentaron un nivel bajo en la dimensión contacto con el rol de la madre.

Los hallazgos de este estudio concuerdan con Mantilla et al.²⁰, demostró 80% (24) presenta un nivel medio, esto implica no tiene un contacto seguro.

Sim embargo, este proceso se lleva a cabo en madres primerizas debido a su inmadurez y el apoyo familiar.

Sin embargo, hay diferencia con el estudio de Santander et al.¹⁹, encontró que el 96,1% presenta nivel bajo. Al igual que Gonzales et al.²¹, nos muestra que el 48% presentan un nivel bajo.

Los resultados de la presente investigación comprueban que las madres presentan un nivel medio, a comparación de los resultados de Santander y Gonzales quienes reportaron un nivel bajo en la dimensión contacto con el rol de la madre.

Tras analizar estos datos de Santander y Gonzales, se observa que las poblaciones encuestadas presentan un nivel bajo, resultado diferente al estudio presentado, donde la población presenta un nivel medio. Aragón et al.³¹ refiere que los factores culturales influyen en el contacto con el rol de la madre, lo que indica que tener menos conocimiento en el afecto del bebé, puede generar patrones negativos en el bienestar óptimo del niño.

Moraima et al.³² indica que contacto con el rol de la madre puede verse afectada por múltiples factores, como culturales tales como: comportamientos y creencias de la madre, en la presente investigación con respecto al indicador evito no contar que soy madre, porque me siento incómodo, estos resultados demuestran que la madre se siente avergonzada de su propio niño, así mismo con respecto al indicador, mi hijo está mejor cuidado cuando lo atiende otro familiar estos indicadores demuestran, la madre no se siente segura de su rol materno en el cuidado de su niño.

Mercer¹⁴ en su teoría, hace referencia que el contacto no solo implica la cercanía física, como abrazos y caricias, sino también la atención, la comunicación y la empatía que una madre ofrece a sus hijos. este tipo de interacción ayuda a los niños a desarrollar vínculos afectivos saludables y a construir su autoestima, lo que refuerza su identidad como madre.

UNICEF³³ en el 2023, afirma que la madre es la guía en la vida de sus hijos, fomentando su independencia y transmitiéndoles amor y respeto, junto con otros valores esenciales. Estos aspectos fundamentales en la crianza no están condicionados por el nivel socioeconómico de la madre o por su nivel de formación profesional.

De acuerdo con lo descrito, es un proceso de construcción de identidad de la madre que establece conexión con su rol materno, donde asume activamente su papel como madre en el cuidado, protección que favorecen el desarrollo integral del niño. Según la NTS para el CRED¹³, menciona que la enfermera es responsable de sensibilizar sobre la importancia del contacto con el rol de la madre, y al mismo tiempo realizar intervenciones que permitan obtener una mayor efectividad del programa, que ayuden a establecer un vínculo que proporcione al niño y la niña sensación de seguridad, ánimo y esperanza fomentando confianza entre ellas mismas, que el aprendizaje del personal de enfermería permita modificar patrones negativos garantizando una buena atención a la madre.

Según, la teórica Mercer, refiere que la enfermera tiene un impacto en la educación, promoción y prevención de la salud del niño, para lograr finalmente un compromiso en el contacto con el rol de la madre.

Con respecto al tercer objetivo específico, se observó que el 99% (78) presentaron un nivel alto, seguidamente el 1% (1) de las madres primerizas presentaron un nivel medio en la dimensión estimulación del bebé.

Se encontró resultados diferentes al estudio de Santander et al¹⁹, donde mencionó que el 72,5% presentan un nivel bajo. Del mismo modo, nos revela Mantilla et al.²⁰, encontró que el 50,0% (15) presentan un nivel bajo, el 33,3% (10) un nivel medio.

Al igual que Gonzales et al.²¹, nos muestra que el 50% mantiene un rol maternal bajo en la dimensión estimulación del bebe.

Los resultados de la presente investigación comprueban que las madres presentan un nivel alto, a comparación de los resultados de Santander y Mantilla quienes reportaron un nivel bajo en la dimensión aceptación del bebé.

Al analizar los resultados de Santander y Gonzales, los porcentajes de la dimensión estimulación del bebe, indican que no se han alcanzado los resultados deseados, el personal de enfermería durante evaluación de CRED, realice una observación frente diferentes estímulos, esto ayudará identificar y canalizar a tiempo una detección temprana. Los hallazgos de la investigación, con respecto al indicador la madre realiza actividades con su hijo, estos resultados demuestran que la madre favorece un vínculo afectivo en su desarrollo integral del niño.

Según Piaget en su teoría argumenta que, el desarrollo psíquico del niño comienza desde el momento del nacimiento, señalando que la inteligencia progresa de manera dinámica en interacción con el entorno y los estímulos, los cuales pueden favorecer o restringir dicho desarrollo.³⁴

Vygotsky ³⁵ explica en su teoría la importancia del aprendizaje, los niños internalizan destrezas y habilidades en la influencia de su entorno físico y social, así mismo se centra en proporcionar oportunidades para la interacción social.

Según las teorías mencionadas, esto demuestra que la estimulación temprana implica el desarrollo habilidades en la primera infancia, mediante un conjunto sistemático de actividades lúdicas y estímulos. donde favorece su desarrollo físico y cognitivo a través de diversas actividades estimulantes.

Según la NTS para el CRED¹³, enfatiza que la enfermera es responsable de evaluar a la niña y el niño desde los 2 días de nacido hasta los 5 años de vida, así mismo

en cada visita al servicio de crecimiento y desarrollo es importante la participación de la madre, donde la enfermera educa y orienta sobre los parámetros estandarizados según las características y edad del niño. Para esta actividad, se utiliza la TPED, que evalúa los comportamientos posturales y visomotores, lenguaje y social. En este período de la valoración la enfermera puede identificar alteraciones o retraso en el desarrollo, para luego fortalecer y mejorar las prácticas de crianza, favoreciendo así un desarrollo integral.

Según, la teórica Mercer, la enfermera tiene un rol en la orientación y educación a las madres sobre la estimulación temprana, ayudándolas a desarrollar habilidades durante su proceso de maternidad, no solo fortalece la confianza materna, si no favorece vínculo afectivo en el desarrollo del niño.

Con respecto al cuarto objetivo específico, se demostró que el 96% (76) presentaron un nivel alto, seguidamente el 4% (3) de las madres primerizas presentaron un nivel medio en la dimensión expresiones maternas de afecto hacia él bebé.

Hallazgos diferentes nos revela el estudio de Mantilla et al.²⁰, señaló que el 63.3% (19) tienen un nivel bajo, el 20% (6) un nivel medio. De igual modo, nos revela Santander R et al.¹⁹, evidenció que el 72,5% es de nivel bajo, 25,5% de nivel medio. Así mismo Gonzales et al.²¹, donde el 40% mantiene un rol maternal bajo.

Los resultados comprueban que las madres presentan un nivel alto, a comparación de los resultados de Mantilla y Stander quienes reportaron un nivel bajo en la dimensión expresiones maternas de afecto hacia él bebé.

Tras analizar estos datos de Mantilla y Stander, se observa que las poblaciones encuestadas presentan un nivel bajo, resultado diferente al estudio presentado,

donde la población presenta un nivel alto. Alparone et al.³⁶ refiere que los factores sociales influyen en las expresiones maternas de afecto hacia el bebé, lo que indica el vínculo afectivo mutuo entre el cuidador principal y el niño.

Davies et al.³⁷ refiere expresiones maternas puede atribuirse a múltiples factores, como emocionales tales como: seguridad, apego y la confianza en sí misma, en la presente investigación con respecto al indicador expreso mi afecto a mi niño mediante palabras cariñosas, estos resultados demuestran que la madre siente esa conexión, seguridad y confianza con su niño, así mismo con respecto al indicador disfruto jugar con mi hijo y que a la vez pueda descubrir algo nuevo, estos indicadores demuestran que la madre no solo desea que su niño juegue, si no aprenda nuevos conocimientos a través de sus experiencias.

Casas³⁸ refiere que las expresiones maternas juegan un papel crucial en el comportamiento humano en todas las etapas de la vida, ejerciendo una influencia significativa. Desde el primer encuentro con su bebé, la mujer experimenta un vínculo afectivo que le proporciona sensaciones de placer y vitalidad.

Además, Raffi et al.³⁹ nos refiere que la interacción inicial entre la madre y el recién nacido suele ser limitada y, en muchos casos, comienza en el entorno hospitalario, por lo que es necesario aclarar este concepto en enfermería. El concepto de afecto maternal se define como un vínculo afectivo que refleja el compromiso amoroso y la protección constante de la madre primeriza, esto implica que la madre por naturaleza, desempeña un papel activo y dinámico en el desarrollo inicial del niño. De acuerdo con lo descrito, las expresiones maternas son emociones y conductas, que la madre expresa afecto de cariño, amor, seguridad, protección y conexión, lo cual son esenciales para el desarrollo emocional, social y mental ya que fortalece el vínculo seguro entre madre e hijo.

Según la NTS para el CRED¹³, destaca que la enfermera es responsable de orientar y enseñar a la madre sobre las expresiones maternas de afecto hacia el bebé, posterior a ello en cada control al servicio de crecimiento y desarrollo, la enfermera educa a la madre, sobre los ítems que se utiliza la Prueba Peruana de Evaluación del Desarrollo, dentro de esta prueba uno de los ítems es que el bebé reacciona al escuchar la voz de su madre, cuando el niño llora debe acariciarlo y sentir calor materno y se muestra alegre cuando recibe lactancia materna. Así mismo la enfermera puede identificar cuáles son las necesidades que tienen el niño, para luego reforzar seguimiento oportuno en la próxima consulta, garantizando un buen desarrollo integral.

Cabe resaltar la importancia de que la enfermera cumple un rol importante en el seguimiento a los niños, con la finalidad fortalecer las prácticas claves para el desarrollo infantil. Esta combinación de roles fortalece un vínculo afectivo y el bienestar emocional del niño.

Con respecto al quinto objetivo específico, se indicó que el 100% (79) presentaron un nivel alto de las madres primerizas en la dimensión bienestar al bebé.

Un estudio con resultados diferentes de Santander et al.¹⁹, estimó que el 87,2% de madres tienen un nivel bajo. Del mismo modo los resultados de Mantilla et al.²⁰ demostró 53,3% (16) de las madres presentan un nivel bajo.

Así mismo Gonzales et al.²¹, encontró que el 46,67% mantiene un rol maternal medio, en la dimensión bienestar al bebé.

Los resultados del estudio comprueban que las madres presentan un nivel alto, a comparación de los resultados de Stander y Gonzales quienes reportaron un nivel bajo y medio respectivamente en la dimensión bienestar al bebé.

Al analizar los resultados de Santander y Gonzales, se observa que las poblaciones encuestadas presentan un nivel bajo y medio, resultado diferente al estudio presentado, donde la población presenta un nivel alto. Tang et al.⁴⁰ refiere que los factores sociales influyen en el bienestar al bebé, lo que indica que tener un apego seguro con el niño, puede tener un impacto profundo y duradero en su salud mental y en su bienestar integral.

Saharoy et al.⁴¹ refiere bienestar del bebé puede atribuirse a múltiples factores, como socioeconómicos tales como: apoyo de la pareja y status económico, en la presente investigación con respecto al indicador si mi niño llora, priorizo su necesidad para atenderlo rápido, estos resultados demuestran que la madre prioriza el bienestar emocional del bebé, así mismo con respecto al indicador dispongo de medicamentos para cuidar a mi niño, estos indicadores demuestran que la madre está preparada y comprometida con la salud y el bienestar de su hijo.

La OPS⁴² en el 2024, tiene como objetivo sensibilizar acerca de la relevancia del cuidado y bienestar de los recién nacidos. Además, proporciona investigación basada evidencia científica para un cuidado neonatal óptima.

La literatura científica indica que el bienestar emocional, es un aspecto esencial que muchas veces pasa desapercibido en la crianza y el cuidado infantil. Aunque es común pensar que la salud mental se desarrolla más adelante en la vida, se ha comprobado que, desde los primeros meses, e incluso desde el nacimiento, el entorno emocional que rodea al niño influye significativamente en su desarrollo cognitivo, emocional y social. Esto facilita no únicamente una infancia saludable y

plena, sino que también prepara para un futuro en el que se sienta seguro, competente y capaz de superar los desafíos a lo largo de su vida.⁴³

Dr. López Pereyra⁴⁴ 2021, sostiene está asociado a una amplia variedad de indicadores que abarcan aspectos físicos, emocionales y sociales vinculados con la salud física y mental, se plantea que las emociones constituyen un componente fundamental del desarrollo humano.

Conforme a lo señalado, el bienestar es un estado integral que abarca el desarrollo físico y cognitivo, que garantiza una óptima salud, nutrición y protección.

Según la NTS para el CRED¹³, menciona que la enfermera es responsable de orientar a la madre sobre el bienestar del bebé, posteriormente en cada control, la enfermera educa a la madre, sobre la importancia del cuidado del cordón umbilical, esquema de vacunación, baño diario, fomentar lactancia materna y la alimentación complementaria. En tal sentido que fortalezcan los conocimientos y el compromiso de los padres, de modo que puedan aplicar en su vida diaria para favorecer el desarrollo integral del niño.

De acuerdo a su enfoque, Mercer, señala que la enfermera cumple un papel clave en la consejería a las madres sobre el bienestar del bebé, fortaleciendo un vínculo afectivo seguro. Esta combinación de roles asegura un desarrollo emocional y bienestar óptimo del niño.

Con respecto al sexto objetivo específico, se reflejó que el 99% (78) presentaron un nivel alto, seguidamente el 1% (1) de las madres primerizas presentaron nivel medio en la dimensión preocupación y protección del bebé.

Santander et al.¹⁹, evidencia resultados diferentes, encontró que el 84,3% tienen un nivel bajo.

Así mismo Mantilla et al.²⁰, determinó que el 36,7% (11) de madres encuestadas presentan un nivel medio. Igualmente, los resultados de estudio de Gonzales et al.²¹, demostró que el 49,70% mantiene un rol maternal medio.

Los resultados comprueban que las madres presentan un nivel alto, a comparación de los resultados de Stander y Mantilla quienes reportaron un nivel bajo y medio respectivamente en la dimensión preocupación y protección del bebé.

Al analizar los resultados de Santander y Mantilla, se observa que las poblaciones encuestadas presentan un nivel bajo y medio respectivamente, resultado diferente al estudio presentado, donde la población presenta un nivel alto. Zachary et al.⁴⁵ refiere que los factores sociales influyen preocupación y protección del bebé, lo que indica que tener un entorno favorable, puede tener un impacto positivo en su desarrollo y bienestar.

Sagone et al.⁴⁶ indica preocupación y protección del bebé puede verse afectada por múltiples factores, como socioculturales tales como: creencias familiar y entorno social, en la presente investigación con respecto al indicador el estado de salud de mi hijo es importante para mí, estos resultados demuestra la dedicación de la salud de su niño, así mismo con respecto al indicador cumplo con el esquema de vacunación fecha indicada, estos indicadores demuestra que la madre tiene una responsabilidad con el bienestar de su niño.

Según la escuela de salud de Rebagliati, 2023, los bebés son particularmente vulnerables a las enfermedades comunes debido a su sistema inmunológico en desarrollo. Afortunadamente, hay medidas preventivas y tratamientos efectivos que pueden ayudar a mantener a los bebés saludables y felices. Para proteger su salud, es esencial adoptar buenas prácticas de higiene, fomentar la lactancia materna, administrar las vacunas recomendadas y evitar el contacto con personas enfermas.

Estas acciones pueden reducir significativamente el riesgo de que tu bebé contraiga enfermedades comunes.⁴⁷

Mienert⁴⁸, define que es un conjunto de cuidados, atenciones y medidas que brindan los padres desde los primeros días de vida., para asegurar su bienestar físico, emocional y su desarrollo saludable, respondiendo a sus necesidades con afecto, seguridad y responsabilidad.

En relación a lo explicado, esto demuestra que es un cuidado integral y constante, donde la madre recibe una orientación sistemática, lo que permite favorecer seguridad y confianza en el cuidado de su niño.

Según la NTS para el CRED¹³, refiere que la enfermera es responsable de educar y orientar a las madres primerizas sobre preocupación y protección del bebé, en cada control al servicio de crecimiento y desarrollo, la enfermera educa a la madre, sobre los signos de alarma, importancia contacto piel a piel, cuidado post vacuna, la higiene y alimentación. De esta manera la enfermera puede identificar cuáles son las necesidades que tiene el niño, para luego brindar una atención oportuna y establecer una retroalimentación que ayude a la madre a manejar las emociones de angustia y preocupación fortaleciendo su seguridad y confianza en el cuidado de su niño.

De acuerdo a su enfoque, la teórica Mercer, indica que la enfermera tiene un papel clave en educar a las madres, desarrollando confianza en su nuevo rol. Esta combinación de roles fortalece un desarrollo y bienestar emocional del niño.

Con respecto al séptimo objetivo específico, el 95% (75) presentaron un nivel alto, seguidamente el 5% (4) de las madres primerizas presentaron un nivel medio en la dimensión interacción con la pareja respecto al bebé.

Hallazgos diferentes nos revela el estudio de Santander et al.¹⁹, determinó que el 69.6% tienen un nivel bajo.

Así mismo Mantilla et al.²⁰ señaló que el 23,3% (7) tiene un nivel medio. Del mismo modo el estudio de Gonzales et al.²¹, estimó que el 46,67% mantiene un rol maternal medio.

Los resultados comprueban que las madres presentan un nivel alto, a comparación de los resultados de Stander y Mantilla quienes reportaron un nivel bajo y medio respectivamente en la dimensión interacción con la pareja respecto al bebé.

Además, las encuestadas tienen un nivel alto. Por otro lado, estudio diferente Stander y Mantilla evidencia un nivel bajo y medio respectivamente. La Rosa et al.⁴⁹ refiere que los factores sociales influyen preocupación y protección del bebé, lo que indica que tener una red de apoyo, puede tener una mejora en el cuidado infantil.

Mutawtah et al.⁵⁰ indica interacción con la pareja respecto al bebé puede verse afectada por múltiples factores, como socioculturales tales como: creencias, practicas familiares, y entorno social, en la presente investigación con respecto al indicador como padres procuramos estar al tanto de nuestro hijo, estos resultados demuestra compromiso parental en el bienestar del niño, así mismo con respecto al indicador mi pareja puede cuidar de nuestro hijo cuando yo no estoy disponible, estos indicadores demuestra que ambos padres comparten la responsabilidad del cuidado .

Marín et al.⁵¹ indica que el papel del padre durante el embarazo varía en cada etapa de la gestación; en algunos momentos es principalmente emocional, mientras que en otros requiere una participación más activa. En cualquier caso, la comunicación continua entre ambos miembros de la pareja es crucial a lo largo del embarazo.

Asimismo, Duarte⁵² señala que la pareja necesita ajustarse a su nuevo papel como padres y afrontar una etapa que desafía la fortaleza de su vínculo. Las responsabilidades que implica el cuidado permanente de un bebé modifican radicalmente las rutinas diarias, lo que puede llevar al cansancio extremo y a enfocar toda la atención exclusivamente en el hijo.

Según lo indicado anteriormente, interacción con la pareja es la clave para el bienestar del bebé, ya que una comunicación efectiva y la toma de decisiones crea un entorno seguro y estable, no solo mejora el desarrollo del bebé, sino que también fortalece el trato de pareja y el equilibrio familiar.

Según la NTS para el CRED¹³, describe a la enfermera como responsable de orientar sobre la importancia interacción con la pareja respecto al bebé, durante la atención se ha observado, que la madre siempre viene acompañada de su pareja, lo que permite es que ambos demuestren iniciativa de aprender y de conocer nuevas experiencias. Cabe mencionar que labor del profesional a través de su consejería, oriente a los padres sobre los cuidados del bebe, promoviendo en ellos compromiso y motivación por aprender, esto les brinda satisfacción por el conocimiento adquirido, lo que refuerza su confianza en brindar un cuidado adecuado en el entorno familiar.

Cabe resaltar la importancia del rol que desempeña la enfermera, que oriente a la pareja, promoviendo en ellos compromiso y motivación por aprender en el cuidado y bienestar del niño.

Con respecto al octavo objetivo específico, el 92% (73) presentaron un nivel alto, seguidamente el 8% (6) de las madres primerizas presentaron un nivel medio en la dimensión interacción con la familia de origen respecto al bebé.

Encontramos un estudio diferente de Santander et al.¹⁹, demostró 73,5% de madres presentan un nivel bajo. Además, Mantilla et al.²⁰, mostró 43,3% (13) de madres presentan un nivel bajo.

Así mismo Gonzales et al.²¹, quien encontró que más del 56,89% mantiene un rol maternal medio, en la dimensión interacción con la familia de origen respecto al bebé.

Los resultados de la presente investigación comprueban que las madres presentan un nivel alto, a comparación de los resultados de Stander y Gonzales quienes reportaron un nivel bajo y medio respectivamente en la dimensión interacción con la familia de origen respecto al bebé.

Los resultados de este estudio comprueban que las encuestadas tienen un nivel alto. Por otro lado, estudio diferente Stander y Gonzales evidencia un nivel bajo y medio respectivamente. Zambrano et al.⁵³ refiere que los factores sociales influyen interacción con la familia de origen respecto al bebé, lo que indica que tener un apoyo familiar, puede favorecer el bienestar emocional de los padres.

La Hoz et al.⁵⁴ indica interacción con la familia respecto al bebé puede verse afectada por múltiples factores, como socioculturales tales como: prácticas culturales, y los valores familiares, en la presente investigación con respecto al indicador mi familia se siente feliz con la llegada de mi bebé, estos resultados demuestra un ambiente familiar favorable, que contribuye vínculo emocional del niño ,así mismo con respecto al indicador mi familia me apoya en el cuidado de mi hijo, estos indicadores demuestra el amor de la familia que favorecen el bienestar y la seguridad del niño.

Fass et al.⁵⁵ considera que la práctica de una comunicación activa en el entorno familiar es crucial, ya que tanto el emisor como el receptor desempeñan papeles

importantes, creando un diálogo e interacción dinámicos. Las relaciones familiares tienen un impacto significativo en el desarrollo físico y emocional del individuo.

Mientras que para Ramos et al.⁵⁶ la familia desempeña un rol fundamental en el crecimiento del niño, ya que este es el espacio que se inicia en la incorporación a la cultura, la asimilación de valores y de los aprendizajes.

Tomando en cuenta lo explicado, esto demuestra que la familia es el eje principal de apoyo, que ayuda construir seguridad y confianza, fortaleciendo el desarrollo integral del niño.

Según la NTS para el control del CRED¹³, describe que la enfermera es responsable de orientar sobre la importancia interacción con la familia respecto al bebé, durante la atención se ha observado, que la madre siempre viene acompañada ya sea de su pareja o de un familiar, permite fortalecer el vínculo familiar generando un entorno que demuestren iniciativa de aprender en el bienestar integral del niño. Cabe mencionar que el profesional de enfermería a través de su consejería, oriente a la familia sobre los cuidados del bebe, acerca de la importancia del cuidado del niño con el objetivo de fortalecer la salud, priorizando una buena adopción del rol maternal.

De acuerdo a su enfoque, la teórica Mercer señala que la enfermera tiene un papel clave en orientar a la familia, desarrollando proceso de adaptación a la maternidad y paternidad promoviendo el crecimiento y desarrollo del niño.

Con respecto al noveno objetivo específico, se reveló que el 100% (79) presentaron un nivel alto de las madres primerizas en la dimensión cuidados del bebé.

Hallazgos diferentes nos muestra Santander et al.¹⁹, demostró que el 87,3% de madres presentan un nivel bajo. Al igual que Mantilla et al.²⁰, determinó que el 56,7% presentaron un nivel bajo en la dimensión cuidados del bebé.

Así mismo Gonzales et al.²¹, nos indica que el 49,87% mantiene un rol maternal medio, en la dimensión cuidados del bebé.

Los resultados de la presente investigación comprueban que las madres presentan un nivel alto, a comparación de los resultados de Stander y Gonzales quienes reportaron un nivel bajo y medio respectivamente en la dimensión cuidados del bebé.

Los resultados de este estudio comprueban que las encuestadas tienen un nivel alto. Por otro lado, estudio diferente Stander y Gonzales evidencia un nivel bajo y medio respectivamente. Reyes et al.⁵⁷ refiere que los factores sociales influyen cuidados del bebé, lo que indica la necesidad de fortalecer las redes sociales, puede garantizar un entorno óptimo para el crecimiento del niño.

Céspedes et al.⁵⁸ indica cuidados del bebé puede verse afectada por múltiples factores, como socioculturales tales como: redes sociales, apoyo personal de enfermería, en la presente investigación con respecto al indicador he recibido orientación del personal enfermería acerca de cómo cuidar a mi niño, estos resultados demuestra la importancia de que el personal de salud, fortalezca la confianza y habilidades del bienestar del niño, así mismo con respecto al indicador tengo la confianza de que seré una madre, estos indicadores demuestra una actitud positiva hacia el rol materno, lo cual fortalece el vínculo afectivo con el niño.

Anzilotti⁵⁹, nos indica que cuidar de un recién nacido también implica cuidar de uno mismo. Es recomendable solicitar apoyo durante este periodo, que a menudo puede sentirse caótica y llena de retos. Mantener a su bebé saludable es crucial,

por lo que cualquier persona que cuide o esté en contacto con su pequeño debe estar en óptimas condiciones de salud.

UNICEF⁶⁰, define que el cuidado es la mejor evidencia sobre el desarrollo infantil. Las familias deben tener los mejores escenarios para apoyar el crecimiento y desarrollo infantil.

Conforme a lo expresado anteriormente, esto demuestra que el cuidado del bebé es una atención integral y continua donde el niño crece en un entorno seguro, afectivo y protegido para fortalecer un óptimo desarrollo integral.

Según la NTS para CRED¹³, menciona que la enfermera es responsable de orientar a la madre sobre el cuidado del bebé, posteriormente en cada control, la enfermera educa a la madre, sobre el fortalecimiento del vínculo afectivo, cumplimiento del esquema de vacunación, baño diario, y la alimentación complementaria. En tal sentido que la madre fortalezca sus conocimientos y habilidades para brindar un cuidado integral y adecuado al niño.

De acuerdo a su enfoque, Mercer, señala que la enfermera tiene un papel clave en la consejería a las madres sobre el cuidado del bebé, fortaleciendo un vínculo afectivo seguro. Esta combinación de roles asegura un desarrollo emocional y bienestar óptimo del niño.

Finalmente, **con respecto al décimo objetivo específico**, el 57% (45) tienen un nivel alto, seguidamente el 43% (34) de las madres primerizas presentaron un nivel medio en la dimensión conocimiento y cultura relacionados al bebé.

Resultados similares a la investigación de Gonzales et al.²¹, nos revela que el 49,87% mantiene un rol maternal alto, en la dimensión conocimiento y cultura relacionados al bebé.

Un estudio con resultados diferentes de Santander et al.¹⁹, obtuvo que el 96,1 % de madres tienen un nivel bajo. Además, Mantilla et al.²⁰ encontró que el 53,3% (16) presentan un nivel bajo.

Los resultados comprueban que las madres presentan un nivel alto, a comparación de los resultados de Stander y Mantilla quienes reportaron un nivel bajo en la dimensión conocimiento y cultura relacionados al bebé.

Los resultados de este estudio comprueban que las encuestadas tienen un nivel alto. Por otro lado, estudio diferente Stander y Mantilla evidencia un nivel bajo y medio respectivamente. Torres et al.⁶¹ refiere que los factores sociales influyen conocimiento y cultura relacionados al bebé, lo que indica que tener una red de apoyo, puede tener una mejora en el cuidado infantil.

González et al.⁶² indica conocimiento y cultura relacionados al bebé puede verse afectada por múltiples factores, como socioculturales tales como: creencias, familiares, redes sociales, en la presente investigación con respecto al indicador investigo temas referentes al cuidado y desarrollo de mi niño, estos resultados demuestra compromiso de la madre para brindar una crianza responsable, así mismo con respecto al indicador con frecuencia me informo mediante programas de cómo cuidar a mi hijo, estos indicadores demuestra que las redes sociales facilitan el aprendizaje y la actualización para el desarrollo del niño.

Zulca et al.⁶³, señala que los conocimientos y habilidades que tanto el niño como la familia contribuyen a la comunidad de aprendizaje son esenciales, tanto como las prácticas y experiencias culturales de las familias, o "fondos de conocimiento", resulta crucial para proporcionar entornos y experiencias educativas que reflejen y respeten la diversidad cultural.

Banda et al. ⁶⁴ indica que cada persona, posee prácticas, creencias, valores y tradiciones propias que deben ser respetadas y consideradas en el ámbito del cuidado en salud, es por ello es necesario el comportamiento de las personas en torno al cuidado, considerando sus contextos culturales, sociales y familiares.

Según las definiciones mencionadas, esto demuestra que son creencias, prácticas y valores que una familia posee y transmite en torno al cuidado, crianza y desarrollo del bebé.

Según la NTS para CRED¹³, señala que el profesional de enfermería es responsable de brindar una atención equitativa, considerando la cultura, condición social, religión, distinciones de género para garantizar una atención de calidad. Ella es responsable de fortalecer la relación con la familia manteniendo una actitud favorable, facilitando la comunicación abierta y efectiva.

Hoy en día debe tomarse como un valor dentro de nuestra cultura en la práctica diaria de enfermería, que no solo se cumpla con el protocolo señalado, sino también ponerlo en práctica los valores éticos que reflejen en cada acción Esta combinación es clave para garantizar una atención humanizada y de alta calidad.

V. CONCLUSIONES

1. Las madres primerizas atendidas en el Centro de Salud Mirones Bajo presentaron un nivel alto en la adopción del rol maternal.
2. Las madres primerizas presentaron un nivel medio en la dimensión aceptación del bebé.
3. Las madres primerizas presentaron un nivel medio en la dimensión contacto con el rol de la madre.
4. Las madres primerizas presentaron un nivel alto en la dimensión estimulación del bebé.
5. Las madres primerizas presentaron un nivel alto en la dimensión expresiones maternas de afecto hacia él bebé.
6. Las madres primerizas presentaron un nivel alto en la dimensión bienestar al bebé.
7. Las madres primerizas presentaron un nivel alto en la dimensión preocupación y protección del bebé.
8. Las madres primerizas presentaron un nivel alto en la dimensión respecto interacción con la pareja respecto al bebé.
9. Las madres primerizas presentaron un nivel alto en la dimensión interacción con la familia de origen hacia al bebé.
10. Las madres primerizas presentaron un nivel alto en la dimensión cuidado del bebé.

11. Las madres primerizas presentaron un nivel alto en la dimensión conocimiento y cultura relacionados al bebé.

VI. RECOMENDACIONES

- 1.** A la jefa de Enfermeras del servicio Crecimiento y Desarrollo se recomienda continuar fortaleciendo este éxito mediante el aprendizaje continuo y actualización de conocimientos de las enfermeras, es fundamental que se mantenga al día con las últimas investigaciones en el rol maternal, el desarrollo infantil y las necesidades específicas de las madres primerizas. Además, fomentar la participación en cursos y eventos científicos para mantener excelencia en la atención.
- 2.** A los directivos del Centro de Salud Mirones Bajo implementar un programa de apoyo integral a madres primerizas: creando grupos de apoyo donde las madres puedan compartir experiencias, resolver dudas y recibir orientación de profesionales. Diseñar talleres educativos sobre temas relevantes como: cuidados del recién nacido, lactancia materna, desarrollo infantil, apego seguro. Establecer un sistema de seguimiento individualizado para identificar a las madres que requieran mayor apoyo y ofrecerles atención personalizada.
- 3.** A la comunidad científica se sugiere un estudio de impacto cuasiexperimental sobre la efectividad de una intervención educativa sobre la adopción del rol maternal.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Organización Mundial de la Salud [Internet]. Lima, Perú: OMS; c2025. Mortalidad neonatal; 14 de marzo 2024 [citado el 15 de agosto de 2024]; [1 pantalla]. Disponible de: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/newborn-mortality>
2. Organización Panamericana de la Salud [Internet]. Lima, Perú: OPS. Tendencias alentadoras y desafíos persistentes: Análisis de mortalidad en menores de 5 años y perspectivas en América Latina y el Caribe; 14 de mayo 2024 [citado el 15 de agosto de 2024]; [1 pantalla]. Disponible de: <https://www.paho.org/es/noticias/14-5-2024-tendencias-alentadoras-desafios-persistentes-analisis-mortalidad-menores-5-anos>
3. Anabel Guzmán V [Internet]. [lugar desconocido]: Studocu; c2025. Salud de la mujer rol materno; [fecha desconocida] [citado el 15 de agosto de 2024]; [1 pantalla]. Disponible de: <https://www.studocu.com/pe/document/universidad-nacional-de-san-antonio-abad-del-cusco/enfermeria-en-salud-de-la-mujer/salud-de-la-mujer-rol-materno/96966910>
4. Instituto Nacional de Estadística e Informática [Internet]. Lima, Perú: INEI; c2024. En el Perú más de ocho millones 777 mil mujeres son madres; 11 de mayo 2024 [citado el 15 de agosto de 2024]; [1 pantalla]. <https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/en-el-peru-mas-de-ocho-millones-777-mil-mujeres-son-madres-13575/>

5. Marin Vera AC, Cartuche Nagua DJ, Paccha Tamay CL. Rol materno en adolescentes primigestas en el primer nivel de atención. Rev. Ciencia Multidisciplinar [Internet]. 2024 [citado el 15 de agosto de 2024]; 8 (1): 9752-9767. Disponible de: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i2.10296
6. Cadena Guerreño BS, Durand Cáceres JM, Mendoza Navarro LD. Adaptación de rol materno en madres adolescentes y adultas a partir de la Teoría de Ramona Merced [tesis de licenciatura en Internet]. Colombia: Universidad Cooperativa de Colombia; 2022 [citado el 15 de agosto de 2024]. 54 p. Disponible de: <https://repository.ucc.edu.co/server/api/core/bitstreams/ac729864-e6e4-45ed-8dc0-fd377e0b2420/content>
7. Verdesoto Manobanda G, Zambrano Remache MA, Morales Huaraca JA. Adopción del rol materno en primíparas según Ramona Mercer [tesis de licenciatura en Internet]. Ecuador: Universidad Nacional de Chimborazo; 2020 [citado el 15 de agosto de 2024]. 43 p. Disponible de: <http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/6750/1/TESIS%20Gabriela%20Alexandra%20Verdesoto%20Y%20Maryorie%20Zambrano%20ENF..pdf>
8. Salas C, Martín M, Bárcenas I, Canorea C, Chiclana C, Serrano E. VI Jornada de salud mental perinatal. Barcelona, España: Editorial Singlantana; 2017. 20 p.
9. Organización Panamericana de la Salud. [Internet]. Lima, Perú: OPS; c2023. La situación de salud - materno Infantil; 9 de setiembre 2024 [citado el 15 de agosto de 2024]; [1 pantalla]. Disponible de: <https://hia.paho.org/es/paises-2022/perfil-peru>

10. Encuesta demográfica y de salud familiar [Internet]. Lima, Perú: ENDES; c2023. Madre tienen en promedio 1,9 hijos en el 2023; 11 de mayo 2024 [citado el 15 de agosto de 2024]; [1 pantalla]. Disponible de: <https://www.gob.pe/institucion/inei/noticias/952773-este-domingo-cerca-de-9-millones-de-madres-conmemoran-su-dia-en-el-peru>
11. Instituto Nacional de Estadística e Informática [Internet]. Lima, Perú: INEI; c2023. 9 millones de madres conmemoran su día en el Perú en el 2023; 11 de mayo 2024 [citado el 15 de agosto de 2024]; [1 pantalla]. Disponible de: <https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/mas->
12. Ministerio de Salud [Internet]. Lima, Perú: MINSA; c2024. Muerte fetal y neonatal acumulado, Perú 2012 al 2023 y 2024; 1 de septiembre 2024 [citado el 15 de agosto de 2024]; [1 pantalla]. Disponible de: <https://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/sala/2024/SE01/mneonatal.pdf>
13. Ministerio de salud [Internet]. Lima, Perú: MINSA; c2017. Norma Técnica de Salud para el Control del Crecimiento y Desarrollo de la niña y el niño menor de 5 años; 11 de setiembre 2017 [citado el 15 de agosto de 2024]; [1 pantalla]. Disponible de: <https://www.saludarequipa.gob.pe/archivos/cred/NORMATIVA%20CRED.pdf>
14. Oyola Naranjo D.J Integración de la práctica y teoría de convertirse en madre, de Ramona Mercer desde una narrativa de enfermería. Colombia: Universidad cooperativa de Colombia; 2023. 21 p.

15. Hernández Sampieri R, Mendoza Torres CP. Metodología de la investigación las rutas cuantitativa cualitativa y mixta. México: Editorial Mexicana; 2021. 753 p.
16. Arias González J.L Diseño y metodología de la investigación. Perú: Editorial Biblioteca Nacional del Perú; 2021.133 p.
17. Feria Avila H. Blanco Gómez MR. Valledor Estevill RF. La dimensión metodológica del diseño de la investigación. Cuba: Editorial Académica Universitaria; 2019.111 p.
18. Garrido Hidalgo MC, Marchan Coronado M. Adopción del rol materno en madres adolescentes primerizas según, grupo de convivencia. Rev. Psicología Trujillo [Internet]. 2021 [citado el 15 de agosto de 2024]; 13 (11): 11-28.
<https://revistas.ucv.edu.pe/index.php/revpsi/article/download/664/638/652>
19. Santander Huillca RC, Torres Huayta J. Adopción del Rol Materno en madres adolescentes primerizas según tipo de convivencia familiar, en el Hospital III Regional Honorio Delgado de Arequipa [tesis de segunda especialidad en Internet]. Perú: Universidad Nacional de San Agustín De Arequipa; 2020 [citado el 3 de febrero de 2025]. 75 p. Disponible de: <https://repositorio.unsa.edu.pe/server/api/core/bitstreams/96459eb5-0913-4f4a-9111-9f8f05772b1f/content>
20. Mantilla E. Jaime J. Castro R. Adopción del rol materno frente al cuidado del recién nacido en madres adolescentes primerizas en el Centro de Salud la Perla-Callao,2023 [tesis de licenciatura en Internet]. Perú: Universidad Nacional del Callao; 2024 [citado el 3 de febrero de 2025]. 94 p. Disponible

de:<https://repositorio.unac.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12952/8907/TE SIS%20-%20MANTILLA-JAIMES-CASTRO.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

21. Gonzales Cajó YF, Urure Velazco IN. Adopción del Rol Materno en madres obre cuidados del recién nacido en madres primíparas que acuden al Hospital Regional de Ica. Rev. Enfermería Vanguard [Internet]. 2022 [citado el 3 de febrero de 2025]; 10 (1): 3-12. Disponible de: <https://revistas.unica.edu.pe/index.php/vanguardia/article/view/452/667>
22. Estrada Zuleta AC, Cervantes Tejada SM, Zarate Brochero AD. Vivencias de madres adolescentes que llevan a sus hijos a atenderse en el control de Crecimiento y Desarrollo del puesto de salud la floresta de cienaga (magdalena) a la luz de la teoría de Ramona Mercer [tesis de licenciatura en Internet]. Colombia: Universidad de Magdalena; 2020 [citado el 3 de febrero de 2025]. 105 p. Disponible de: <https://repositorio.unimagdalena.edu.co/items/1a134ab7-eeaf-4f64-8a14-7900e0aa1c20>
23. Chasi Hurtado CI. Guambuguete Aguachela EK. Factores que influyen en la adopción del rol maternal en gestante primíparas en el área de ginecología del Hospital Liborio Panchana Sotomayor período Junio - Septiembre 2024 [tesis de licenciatura en Internet]. Ecuador: Universidad Técnica de Babahoyo; 2024 [citado el 3 de febrero de 2025]. 72 p. Disponible de: <https://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/17435/TIC-UTB-FCS-ER-000081.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
24. Vásquez Munive M. Romero Cardenas A. Afectación rol maternal. Debido a la pandemia Colombia: Universidad del Magdalena; 2021.10 p.

25. Helen Rogers AH, Elisabeth Homer CS. Responder a las necesidades de salud de las mujeres de origen migrante y refugiado Rev. Health and social care [Internet]. 2020 [citado el 3 de febrero de 2025]; 28 (1): 1343-1365. Disponible de: <https://doi.org/10.1111/hsc.12950>
26. Figueiredo Souza AL. Maternidad en las redes sociales de internet. Vivencias maternas brasileñas compartidas en red Rev. Académicas de la Universidad de Chile [Internet]. 2020 [citado el 3 de febrero de 2025]; 29 (41): 54-56. Disponible de: <https://orcid.org/0000-0002-1368-3184>
27. Gansauskas de Andrade B, Alves de Assis C, Melo Lima DC, Faleiros Neves L, Aparecida da Silva L, Cera Da Silva R et al. Apoyo social y resiliencia: una mirada a la maternidad adolescente Rev. Acta Paulista enfermagem [Internet]. 2022 [citado el 3 de febrero de 2025]; 35 (1): 1-8. Disponible de: <https://www.scielo.br/j/appe/a/tBRHcGN6MVDL4fRpYVCrS7H/?format=pdf&lang=en>
28. Rachel Logan D [Internet]. [lugar desconocido]: Blog; c2020. Vínculo emocional madre - bebé en el embarazo; 15 de octubre 2020 [citado el 3 de febrero de 2025]; [1 pantalla]. Disponible de: <https://www.canvis.es/el-vinculo-emocional-madre-bebe-en-el-embarazo/#:~:text=Los%20cambios%20de%20%C3%A1nimo%20de,un%20impacto%20en%20el%20feto.>
29. Rachel Logan D [Internet]. [lugar desconocido]: Studyingnurse; c2025. Teoría del logro del rol maternal de Ramona Mercer; 7 de marzo 2025 [citado el 3 de febrero de 2025]; [1 pantalla]. Disponible de: <https://studyingnurse-com.translate.goog/nursing-theory/ramona-mercero>

maternal-role-attainment-

theory/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc

30. Dimas Villarreal E [Internet]. [lugar desconocido]: Psicdv; c2025. Crianza consciente y aceptación emocional; 21 de abril 2025 [citado el 3 de febrero de 2025]; [1 pantalla]. Disponible de: <https://psicdv.com/crianza-consciente-y-aceptacion-emocional/>
31. Aragón Luna E, Herrera Fernández M, Cortez Ayala L. Creencias culturales asociadas en mujeres jóvenes Yucatán, Mexico. Rev. costarricense de Psicología [Internet]. 2024 [citado el 3 de febrero de 2025]; 43 (1): 1659-2913. Disponible de: <http://dx.doi.org/10.22544/rcps.v43i01.03>
32. Moraima del Toro R, Barrios Puerta Z, Borre Ortiz Y. Creencias y prácticas culturales de madres adolescentes en el cuidado de sus hijos menores de 5 años. Rev. electrónica trimestral de Enfermería [Internet]. 2022 [citado el 3 de febrero de 2025]; 21 (67): 1695-6141. Disponible de: <https://dx.doi.org/10.6018/eglobal.507631>
33. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [Internet]. Asunción, Paraguay: UNICEF; c2023. Participación de las familias en el cuidado y educación en la primera infancia; 11 de junio 2023 [citado el 6 de febrero de 2025]; [1 pantalla]. Disponible de: <https://www.unicef.org/paraguay/media/9401/file/Participaci%C3%B3n%20de%20las%20familias%20en%20el%20cuidado%20y%20la%20educaci%C3%B3n%20en%20la%20primera%20infancia.pdf>
34. Facultad de medicina UNAM. Estimulación temprana [video en Internet]. YouTube. 6 de enero de 2021 [citado el 6 de febrero de 2025]. Disponible de: https://unamglobal.unam.mx/global_revista/estimulacion-

temprana/#:~:text=La%20estimulaci%C3%B3n%20temprana%20es%20la,las%20%C3%A1reas%20del%20desarrollo%20humano.

35. Prezi. Vigotsky y la estimulación temprana [video en Internet]. YouTube. 28 de septiembre de 2020 [citado el 6 de febrero de 2025]. Disponible de: https://prezi.com/g7l_4cdaoiey/vigotsky-y-la-estimulacion-temprana/
36. Alparone D, Lucia la Rosa V, Commodari E. Factores psicológicos y sociales que influyen en el vínculo madre-hijo durante el primer año de vida: un modelo para promover el bienestar materno e infantil: Universidad de Bretaña Occidental, Brest, Francia; 2025.16 p.
37. Davies SM, Christiansen SA. Fallon V. Vínculo materno infantil y percepciones del temperamento infantil: el papel mediador de la salud mental materna. Pubmed [Internet]. 2021 [citado el 6 de febrero de 2025]; 282 (4): 1323-1329. Disponible de: doi: 10.1016/j.jad.2021.01.023
38. Plan Internacional Perú. Rol de padres y madres en la formación de la responsabilidad [video en Internet]. YouTube. 20 de octubre de 2020 [citado el 22 de julio de 2025]. Disponible de: <https://www.youtube.com/watch?v=sfrBfHMYvgA>
39. Rafii Forough PH, Alinejad Naeini M. El logro del rol materno. Pubmed [Internet]. 2020 [citado el 22 de julio de 2025]; 25 (4): 304-313. Disponible de: https://pmc-ncbi-nlm-nih.gov.translate.google/articles/PMC7494165/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc
40. Tang Yu S, Lin Ma Y. Los efectos de las relaciones madre-padre en la competencia socioemocional de los niños: el modelo de mediación en cadena de la expresión emocional parental y el apego padre-hijo. Rev Elseiver

- [Internet]. 2023 [citado el 22 de julio de 2025]; 155 (1): 107-277. Disponible de: <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.107227>
41. Saharoy R, Potdukhe A, Wanjari M, Taksande A. Depresión posparto y atención materna: exploración de sus efectos complejos en madres y bebés. Pubmed [Internet]. 2023 [citado el 22 de julio de 2025]; 15(7): 1-5. Disponible de: <https://translate.google.com/website?sl=en&tl=es&hl=es&client=srp&u=https://doi.org/10.7759/cureus.41381>
42. Organización Panamericana de la Salud [Internet]. Lima, Perú: OPS. Campaña de los 28 días - Salud del recién nacido; 21 de abril 2024 [citado el 22 de julio de 2025]; [1 pantalla]. Disponible de: <https://www.paho.org/es/campanas/campana-28-dias-salud-recien-nacido>
43. Bbtips. Como crear vínculo entre papa y bebé [video en Internet]. YouTube. 10 de Setiembre de 2024 [citado el 22 de julio de 2025]. Disponible de: https://www.youtube.com/watch?v=_MOaCQCP8G4&t=1s
44. López Pereyra M, Gómez Vega MP, Armenta Hurtarte C, Puerto Díaz O. Bienestar emocional de la niña y el niño. Rev. Internacional de Educación Emocional y Bienestar [Internet]. 2021 [citado el 22 de julio de 2025]; 1 (2): 53-70. Disponible de: https://ri.iberro.mx/bitstream/handle/iberro/5956/RiEEB_01_02_53.pdf?sequence=1
45. Zachary Radcliff P. [Internet]. [lugar desconocido]: Kidshealth; c2023. Miedo y preocupaciones de la infancia; 11 setiembre 2023 [citado el 22 de julio de 2025]; [1 pantalla]. Disponible de: <https://kidshealth.org/es/parents/anxiety.html>

46. Sagone E, Commodari E, Indiana M, La Rosa V. Explorando la asociación entre el estilo de apego, el bienestar psicológico y el estado de la relación en adultos jóvenes y adultos: un estudio transversal. Rev Europea de Investigación en Salud, Psicología y Educación [Internet]. 2023 [citado el 22 de julio de 2025]; 13 (3): 525 - 539. Disponible de: <https://www.mdpi.com/2254-9625/13/3/40>
47. Escuela de Salud Rebagliati [Internet]. Lima, Perú; c2023. Cuidado y prevención: Como proteger a tu bebe de las enfermedades comunes; 15 de noviembre 2023 [citado el 22 de julio de 2025]; [1 pantalla]. Disponible de: <https://rebagliatisalud.edu.pe/cuidado-y-prevencion-como-proteger-a-tu-bebe-de-las-enfermedades-comunes/>
48. Mienert M. [Internet]. [lugar desconocido]: Pampers; c2022. Guía completa de protección para bebés en casa; 8 de setiembre 2022 [citado el 22 de julio de 2025]; [1 pantalla]. Disponible de: <https://www.pamperslatam.com/bebe/una-casa-segura-para-tu-bebe/articulo/proteccion-para-bebes-en-tu-casa>
49. La Rosa V, Sommerfeld S, Engel K, Commodari E. Del confinamiento a la cuna: Afrontando los desafíos psicológicos del parto durante la pandemia de COVID-19 en Italia: evidencia de un análisis de 3 años. Rev Psicología [Internet]. 2024 [citado el 22 de julio de 2025]; 43 (1): 35616-35629. Disponible de: <https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-023-06089-0>
50. Al-Mutawtah M. Campbell E. Kubis H, Erjavec M. Experiencias de apoyo social de las mujeres durante el embarazo: una revisión sistemática

- cualitativa. Rev Pregnancy and Childbirth [Internet]. 2023 [citado el 22 de julio de 2025]; 23 (1): 2-19. Disponible de: doi: 10.1007/s12144-024-06603-3
51. Marín Iral MP, Quintero Córdova PA, Rivera Gómez SC. Influencia de las relaciones familiares en la primera infancia. Rev Poiésis [Internet]. 2019 [citado el 22 de julio de 2025]; 36 (6): 164-183. Disponible de: <https://doi.org/10.21501/16920945.3196>
52. Instituto Nacional de Estadística e Informática [Internet]. Lima, Perú: INEI; 2023. Factores de riesgo, características y tendencias salud materno - infantil en madres de 15 a 19 y de 25 a 29; 8 de octubre 2022 [citado el 22 de julio de 2025]; [1 pantalla]. Disponible de: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0561/Libro.pdf
53. Zambrano Vélez W, Tómalá Chavarria M. El rol de la familia en el aprendizaje de los niños de Educación Inicial. Rev Internacional de Estudios [Internet]. 2022 [citado el 22 de julio de 2025]; 3 (2): 2675-9780. Disponible de: <https://journals.sapienzaeditorial.com/index.php/SIJIS/article/download/260/179/768>
54. La Hoz Martínez A. Psicoterapia del grupo familiar: padres-bebés. Sistema vincular familiar. Rev Dialnet [Internet]. 2021 [citado el 22 de julio de 2025]; 17 (64): 65-75. Disponible de: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7752322.pdf>
55. Fass AE, Codosea LE, Ferrero MJ, Herrero MI, Marasca R, Nanzer C, et al. Interacciones vinculares mama bebe: impacto de la creencia de las madres. 2da ed. Argentina: Editorial Latinoamérica Ciencia Sociales; 2022. 240 p.

56. Aldeas Infantiles [Internet]. Bogotá, Colombia; c2022. ¿Cuál es la importancia de la familia en el desarrollo?; 19 de agosto 2022 [citado el 22 de julio de 2025]; [1 pantalla]. Disponible de: <https://www.aldeasinfantiles.org.co/noticias/2022/importancia-de-la-familia>
57. Reyes Mera M, Casanova Castillo M, Gualpa Lema D, Aguirre Mendoza J, Santos Briones M, Ponce Quijije L. Cuidados del bebé recién nacido sano. Rev Científica Mundo de la investigación y el conocimiento [Internet]. 2020 [citado el 22 de julio de 2025]; 4 (1): 390-402. Disponible de: <https://recimundo.com/index.php/es/article/view/766>
58. Céspedes Omontes B, Loarte Huaynate P. Conocimiento sobre los cuidados del recién nacido. Rev Ciencia de la salud [Internet]. 2024 [citado el 22 de julio de 2025]; 10 (2): 69-77. Disponible de: <https://uhsalud.com/index.php/revhispano/article/view/762/412>
59. Anzilotti AW. Guía para padres primerizos. España: Editorial Arcopress; 2021. 240 p.
60. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [Internet]. Ciudad de Panamá, Panamá: UNICEF; c2019. Cuidado para el desarrollo infantil; [fecha desconocida] [citado el 22 de julio de 2025]; [1 pantalla]. Disponible de: <https://www.unicef.org/lac/media/8501/file/Prefacio.pdf>
61. Torres Calderón A, Chipana Calderón Mamani Flores A. Percepción cultural del “embarazo y parto”, en las comunidades campesinas. Rev investigación Valdizána [Internet]. 2021 [citado el 22 de julio de 2025]; 15 (3): 161-169. Disponible de: <https://www.redalyc.org/journal/5860/586068621004/html/>
62. González Gavilema N, Mera Herrera V. Mitos y verdades desde un enfoque cultural en el cuidado del recién nacido. Rev Dialnet [Internet]. 2023 [citado el

22 de julio de 2025]; 25 (4): 1-18. Disponible de:
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9454593.pdf>

63. Zulca MT. Tener conocimientos específicos sobre la cultura del niño y la familia es esencial. Estados Unidos: Head Start; 2024. 1 p.

64. Banda Pérez AJ, Álvarez Aguirre A, Casique Casique A. Cuidados en el recién nacido de acuerdo a creencias y costumbres en diferentes culturas. Rev. Cietna para el cuidado de la salud [Internet]. 2020 [citado el 22 de julio de 2025]; 7 (1): 109-115. Disponible de:
<https://doi.org/10.35383/cietna.v7i1.348>

VII. ANEXOS

ANEXO 1: INSTRUMENTO PARA EVALUAR ADOPCION ROL MATERNAL

I. PRESENTACIÓN:

Buenos días, soy egresada de la Universidad San Martín de Porres, estoy realizando un estudio, cuyo objetivo es determinar el rol maternal en madres primerizas en el cuidado del niño menor 1 año. Pedimos su colaboración para que nos facilite ciertos datos que nos permitirán llegar al objetivo de estudio ya mencionado.

II. INSTRUCCIONES GENERALES

Estimada madre su participación en esta encuesta es fundamental para evaluar adopción rol maternal en madres primerizas. Por favor responda con total sinceridad, las siguientes preguntas. Su aporte contribuirá a mejorar la atención del cuidado de su niño.

Edad:

Menor de 18 años () 18 a 25 años () 26 a 35 años () 36 a 45 ()

Estado Civil:

Soltera () Casada () Conviviente () Divorciada () Viuda ()

Grado de instrucción:

Sin instrucción () Primaria () Secundaria () Técnico () universitario ()

Datos del bebé:

Edad del bebé:

Rn () 1 a 3m () 4 a 8 m () 9 a 11 m ()

Sexo del bebé:

Masculino () Femenino ()

A continuación, encontrará una lista de afirmaciones respecto a su experiencia como madre. Deberá elegir, marcando con un aspa (X), la opción que más se asemeje a su forma de pensar, actuar y sentir. No hay respuestas buenas ni malas. Las opciones de respuesta son las siguientes:

TA = Totalmente de Acuerdo.

A= De acuerdo.

O= Desacuerdo.

TD=Totalmente en desacuerdo

N°	Preguntas	Totalmente de acuerdo	Acuerdo	Desacuerdo	Totalmente de acuerdo
1	Prefiero no dar de lactar a mi niño, para cuidar la estética de mis senos				
2	Imito los balbuceos y sonido que hace mi hijo.				
3	Estoy dispuesta a cambiarle el pañal a mi niño cada vez que éste lo necesite.				
4	Leo información referente a los cuidados y temas relacionados a mi niño				
5	Me cuesta aceptar a este niño				
6	Cuando mi niño llora dejo lo que estoy haciendo y voy a atenderlo.				
7	Pienso que la lactancia deberá ser sustituida por la alimentación en biberón				
8	Me cuesta decir soy madre.				
9	Me siento capaz de salir adelante con mi niño.				
10	Mi familia está contenta con el nacimiento de mi niño.				
11	Le doy objetos a mi niño para que los pueda tocar y aprenda a manipularlos.				
12	Mi pareja y yo siempre estamos poniéndonos al tanto de las cosas que le pasan al niño.				
13	Cuando mi niño llora, le hablo con voz muy baja y susurrando palabras tranquilizadoras.				
14	Prefiero ser yo quien se encargue del baño de mi niño.				
15	Cuando estaba gestando pensaba con entusiasmo en el momento en que tendría a mi niño en brazos dándole d lactar				
16	Pienso que el "crecimiento y desarrollo" no es necesario para mi niño				
17	El personal de salud me ha enseñado cuidados que debo tener con mi niño				
18	Cuando le hablo a mi niño le hablo con palabras cariñosas.				
19	Cuando juego con mi hijo me gusta que él aprenda algo nuevo.				
20	Cuando doy de lactar a mi niño me gusta hablarle.				
21	Me gusta mirar detenidamente a mi niño intentándolo conocerlo				

22	Me hubiera gustado que mi niño sea del sexo opuesto al que nació.				
23	El momento de juego con mi niño es indispensable en mi rutina diaria.				
24	La salud de mi niño para mí es muy importante.				
25	Para mí dar de lactar es más una obligación que una actividad agradable.				
26	Cuando mi niño responde a mis cuidados, caricias u órdenes, yo lo abrazo o felicito.				
27	Me agrada masajear la espalda de mi niño con mucha delicadeza.				
28	Mi pareja me hace recordar cuando nuestro niño debe recibir sus vacunas y asistir al control de niño sano.				
29	Prefiere que alguien de mi familia se encargue de alimentar a mi niño.				
30	Mientras doy de lactar a mi niño me gusta acariciarlo.				
31	Cuando cosquileo a mi niño observo una respuesta de alegría en él.				
32	Cuando voy a un lugar público hago valer mis beneficios por ser madre y estar con mi hijo en brazo.				
33	Aunque tenga muchas actividades que realizar, siempre me doy tiempo para cuidar de mi niño.				
34	Constantemente me informo por programas de televisión de cómo cuidar a mi hijo.				
35	Hago vacunar mi niño en la fecha programada.				
36	Sé que cuento con el apoyo de mi familia para el cuidado de mi niño.				
37	Prefiero que mi hijo tome biberón a darle de lactar.				
38	Trato que mi niño acaricie mi rostro.				
39	Tengo la seguridad que seré una buena madre.				
40	Mi pareja y yo compartimos el cuidado del niño.				
41	Cuido que mi niño utilice ropa adecuada a la estación para evitar que se enferme.				
42	Creo que dar de lactar une emocionalmente a las madres con sus hijos.				
43	Me alegra mucho que mi hijo haya nacido sano.				

Activar Windo

44	Cada vez que mi niño llora me preocupo por saber qué es lo que necesita.				
45	La forma en que crío a mi niño es muy parecida a cómo me criaron a mí.				
46	Mi familia me aconseja sobre la crianza de mi niño.				
47	Me preocupo porque a su alrededor no existan objetos que puedan hacerle daño a mi niño				
48	Trato de ocultar el hecho de que tengo un niño porque me da vergüenza.				
49	Creo que otro familiar cuida a mi niño mejor que yo				
50	Terceras personas se encargan de la crianza de mi niño.				
51	Si voy por la calle y alguien estornuda cerca, lo primero que hago es cubrir a mi niño				
52	Mi pareja es capaz de hacerse cargo de nuestro niño cuando yo no lo puedo hacer.				
53	Practico con mi niño ejercicios que le puedan ayudar a su desarrollo.				
54	Diariamente mi pareja busca saber cómo está el niño y coordinamos acerca de cómo satisfacer sus necesidades.				
55	Las cosas que aprendí sobre el cuidado de mi niño me las enseñaron las personas que me criaron				
56	Tengo en casa medicamentos necesarios para lo que requiere mi niño en caso se enferme.				

ANEXO 2: CONSENTIMIENTO INFORMADO

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Institución: Universidad San Martín de Porres

Investigadora: Carla Ivette Carrasco Villarreal

Título: Adopción del rol maternal de las madres primerizas en el cuidado del niño menor de 1 año, en el servicio de crecimiento y desarrollo del Centro de Salud Mirones Bajo, 2025.

Yo doy mi consentimiento para participar en el estudio y soy consciente de que mi participación es enteramente voluntaria.

He recibido información en forma verbal sobre el estudio mencionado. He tenido la oportunidad de discutir sobre el estudio y hacer preguntas.

Al firmar este protocolo estoy de acuerdo con que mis datos personales, incluyendo datos relacionados a mi salud física y mental o condición, y raza u origen étnico, puedan ser usados según lo descrito en la hoja de información que detalla la investigación en la que estoy participando.

Entiendo que puedo finalizar mi participación en el estudio en cualquier momento, sin que esto represente algún perjuicio para mí.

Entiendo que recibiré una copia de este formulario de consentimiento e información del estudio y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo comunicarme con **con la investigadora.**

Dentro de los beneficios está la contribución al desarrollo de la investigación, la cual servirá de aporte científico a la mejora continua con resultados que podrán extenderse a ámbitos nacionales.

Nombre completo del participante

Firma

Fecha

Nombre del Investigador

Firma

Fecha

ANEXO 3: OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE

Variable	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición
Adopción del rol maternal en las madres primerizas.	Se evaluará mediante un cuestionario que determinará competencias medidas con los estándares de alto, medio y bajo. Este fue elaborado por el autor Garrido y Marchan, 2011, Perú, lleva por título "Escala de Adopción del Rol Materno" ⁴²	Aceptación del bebe	Aceptación, vínculo, apego.	Ordinal - Nivel Alto - Nivel Medio - Nivel Bajo
		Contacto con el rol de madre.	Percepción y adopción del rol maternal.	
		Estimulación del bebe	Estimulación social, coordinación motora y lenguaje.	
		Expresiones maternas de afecto hacia el bebe.	Afectividad.	
		Bienestar del bebe	Cuidado, alimentación, seguridad.	
		Preocupación y protección del bebe.	Protección del bebé.	
		Interacción con la pareja respecto al bebe.	Cuidados del padre.	
		Interacción con la familia de origen respecto al bebe.	Compartir cuidados, compartir responsabilidades, aceptación.	
		Cuidados del bebe.	Salud, alimentación, protección	
		Conocimiento y cultura relacionados al bebe.	Conocimiento sobre el cuidado, estimulación, respeto.	

ANEXO 4: CARTA DE ACEPTACIÓN DEL C.S MIRONES BAJO

	PERU Ministerio de Salud	Ministerio de Salud Dirección de Redes Integradas de Salud	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
---	------------------------------------	---	---

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de Bicentenario de la Consolidación de nuestra independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

CONSTANCIA N° 70

**AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
ACTA N°12 -2024-COM.INV-DIRIS-LC
EXPEDIENTE N.º 202462019**

La que suscribe, Directora General de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, da Constancia que:

CARRASCO VILLARREAL CARLA IVETTE

Autora del Proyecto de Investigación: " ADOPCION DEL ROL MATERNAL DE LAS MADRES PRIMERIZAS EN EL CUIDADO DEL NIÑO MENOR DE 1 AÑO, EN EL SERVICIO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL CENTRO DE SALUD MIRONES BAJO,2024" ha cumplido con los requisitos exigidos por la Unidad Funcional de Docencia e Investigación y el Comité de Investigación de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, dando por **APROBADO**, la Autorización para la Ejecución del Proyecto de Investigación, teniendo una vigencia de:

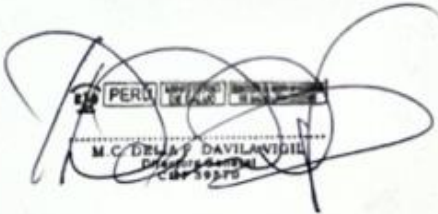
FECHA DE INICIO : 14 de Noviembre del 2024.
FECHA DE TÉRMINO : 31 de Mayo del 2025.

Asimismo, se le informa que su responsabilidad culmina con la presentación del informe Final, la publicación y socialización de resultados con las Oficinas, Estrategias y Establecimientos de Salud de interés de la jurisdicción, en bien de la Salud Pública del País.

Esperando el cumplimiento de todo lo antes mencionado, quedo de usted.

Lima, 13 de Noviembre del 2024.

Atentamente,






ANEXO 5: APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA



Jesús María, 01 de octubre de 2024

Oficio N°103-2024-ININ-FOEHZBN-USMP

Doctora

VICTORIA ALIAGA BRAVO

Directora de la Oficina de Grados y Títulos

Facultad de Obstetricia y Enfermería

"Hilda Zoraida Baca Neglia" - USMP

Presente.-

Ref.: Oficio N° 467-2024-GYT-FOEHZBN-USMP

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y en atención al oficio de la referencia, remitirle la revisión realizada por el Comité de Ética e Investigación sobre la base de los 3 indicadores detallados a continuación.

1. El plan va acorde con la política y líneas de investigación de la institución.
2. Los objetivos del plan son claros y adecuados.
3. Los aspectos éticos de la investigación son claros y corresponden según el objetivo de la investigación.

Señalarle que el plan de investigación de la Srta. **CARRASCO VILLARREAL, CARLA IVETTE** egresada de la ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, a criterio de los miembros del Comité, **CUMPLE.**

Agradeciendo anticipadamente su atención, aprovecho la ocasión para renovar los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

Dra. Ysis Judith Roa-Meggo
Presidente del Comité de Ética
Facultad de Obstetricia y Enfermería
Hilda Zoraida Baca Neglia

YRM:shr

Aq./ Pae de Investigación E. CARRASCO

Facultad de Obstetricia y Enfermería
"Hilda Zoraida Baca Neglia"
Av. Salaverry 1136-1144, Jesús María, Lima
<https://usmp.edu.pe/foe/>
<https://www.facebook.com/foe.usmp>

**ANEXO 6: FÓRMULA PARA CÁLCULO DE MUESTRAS DE POBLACIONES
FINITAS**

$$n: \frac{(1.96)^2 (0.5) (0.5) (100)}{(0.05)^2 (100 - 1) + (1.96)^2 (0.5) (0.5)}$$

$$n: \frac{3.8416 (25)}{(0.0025) (99) + (3.8416) (0.5) (0.5)}$$

$$n: \frac{96.04}{(0.2475) + (0.9604)}$$

$$n: \frac{96.04}{(1.2079)}$$

$$n: 79 \text{ madres}$$

ANEXO 7: HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN

Tabla 12. Características sociodemográficas de las madres en el servicio de crecimiento y desarrollo del Centro de Salud Mirones Bajo 2025.

CATEGORIAS	INDICADORES	N	%
EDAD DE LA MADRE	Menor de 18 años	1	1%
	18 a 25 años	11	14%
	26 a 35 años	62	79%
	36 a 45 años	5	6%
	Total	79	100%
GENERO	Femenino	47	60%
	Masculino	32	40%
	Total	79	100%
ESTADO CIVIL	Soltera	21	27%
	Casada	4	5%
	Conviviente	54	68%
	Divorciada	0	0%
	Viuda	0	0%
	Total	79	100%
GRADO DE INSTRUCCIÓN	Sin instrucción	0	0%
	Primaria	1	1%
	Secundaria	59	75%
	Tecnico	13	16%
	Universitario	6	8%
	Total	79	100%
EDAD DEL BEBE	Recien nacido	2	3%
	1 a 3 meses	22	28%
	4 a 8 meses	46	58%
	9 a 11 meses	9	11%
	Total	79	100%

En la tabla 12, se observa que del 100% de la población, con relación a los rangos de la edad de la madre, el 79%(62) de las madres tienen de 26 a 35 años, el 14% (11) tienen entre 18 a 25 años, el 6% (5) tienen de 36 a 45 % y el 1% menos de 18 años, en cuanto al género , en este estudio el 60% (47) son de sexo femenino ,y el 40% (32) son de sexo masculino ,respecto al estado civil predomina el 68%(54) son convivientes, el 27% (21) madres solteras y solo el 5%(4) casadas, en cuanto al grado de instrucción el 75%(59) tienen secundaria completa , el 16%(13) grado técnico, el 8%(6) grado superior y el 1% tiene primaria, finalmente la edad del bebe tenemos que el 58% (46) tiene de 4 a 8 meses, el 28% (22) de 1 a 3 meses , el 11% (9) de 9 a 11 meses y finalmente el 3% (2) son recién nacidos.